

HISTORY TAKING

أخذ القصة المرضية (الاستجواب السريري)

الأستاذ حسن نصر الله | Professor Hassan Nassrullah

1. OBJECTIVES AND PRINCIPLES | الأهداف والمبادئ

Objectives

الأهداف

Knowledge (المعرفة)

- Understand the basic components of history taking (chief complaint, history of present illness, etc.).
فهم المكونات الأساسية لأخذ القصة المرضية (الشكوى الرئيسية، قصة المرض الحالي، إلخ).
- Recall the importance of each part of the history in aiding diagnosis.
تذكر أهمية كل جزء من القصة في المساعدة على التشخيص.

Comprehension (الاستيعاب)

- Explain the significance of patient history in confirming diagnoses, as over 60% of diagnoses are made from history alone.
شرح أهمية قصة المريض في تأكيد التشخيص، إذ إن أكثر من 60% من التشخيصات تُجرى من القصة وحدها.

Application (التطبيق)

- Apply effective communication skills during patient interviews.
تطبيق مهارات التواصل الفعالة أثناء مقابلات المرضى.
- Use appropriate techniques in different clinical settings (outpatient, inpatient, emergency).
استخدام تقنيات مناسبة في الأوساط السريرية المختلفة (العيادة الخارجية، المرضى المقيمين، الطوارئ).

Analysis (التحليل)

- Analyse symptoms to differentiate between normal and abnormal findings.
تحليل الأعراض للتمييز بين الموجودات الطبيعية وغير الطبيعية.
- Evaluate the patient's responses to identify potential diagnoses.
تقييم استجابات المريض لتحديد التشخيصات المحتملة.

Synthesis (التركيب)

- Integrate information from the history to formulate a provisional diagnosis.
دمج المعلومات من القصة لصياغة تشخيص مبدئي.
- Develop a comprehensive patient profile that includes social, medical, and family histories.
بناء ملف شامل للمريض يتضمن القصص الاجتماعية والطبية والعائلية.

Evaluation (التقييم)

- Assess the effectiveness of the history-taking process.
تقييم فعالية عملية أخذ القصة.
- Reflect on the accuracy of provisional diagnoses based on the gathered history.
التأمل في دقة التشخيصات المبدئية المبنية على القصة المجموعة.

Why Do We Take History from the Patient?

لماذا نأخذ القصة من المريض؟

- To confirm the diagnosis.

لتأكيد التشخيص.

- In more than 60% of patients a diagnosis is made from the history.

في أكثر من 60% من المرضى يُجرى التشخيص من القصة.

How Do We Take History? What Do We Need?

كيف نأخذ القصة؟ ماذا نحتاج؟

- Available patients.

مرضى متاحون.

- Appropriate setting.

مكان مناسب.

- A place and time that are as comfortable as possible.

مكان ووقت مريحان قدر الإمكان.

- Patience and understanding.

صبر وتفهم.

- Knowledge.

معرفة.

- Good communication skills.

مهارات تواصل جيدة.

- Experience.

خبرة.

Set-up of History Taking

تهيئة أخذ القصة

- In the outpatient clinic: a short but effective, focused and informative history.

في العيادة الخارجية: قصة قصيرة لكنها فعّالة ومركّزة وغنية بالمعلومات.

- In the inpatient clinic: a long classical history.

في العيادة الداخلية (المرضى المقيمين): قصة كلاسيكية طويلة.

- In the emergency room: the chief complaint, followed by checking the vital signs and then the secondary survey.

في غرفة الطوارئ: الشكوى الرئيسية يليها فحص العلامات الحيوية ثم المسح الثانوي.

(Figure: photographs of a doctor–patient interview in the clinic.)

(الشكل: صور لمقابلة بين طبيب ومريض في العيادة.)

Don't Forget To

لا تنس أن

- Introduce yourself to the patient and explain to him or her what you are going to do.

تعرف بنفسك إلى المريض وتشرح له ما ستفعله.

- Ask them what they like to be called (e.g. sir, madam, doctor, professor, ...).
تسأله بماذا يحب أن يُنادى (مثل سيدي، سيدتي، دكتور، بروفيسور، ...).
- Get a chaperon when you interview a female patient.
تصطحب مرافقة عند مقابلة مريضة أنثى.
- Be a good listener, at the same time take control of the session.
تكون مستمعاً جيداً وفي الوقت نفسه تتحكم بسير الجلسة.
- Use a lot of body language in your communication with the patient.
تستخدم الكثير من لغة الجسد في تواصلك مع المريض.

2. COMPONENTS OF THE HISTORY | مكونات القصة المرضية

First: Identification Data

أولاً: المعطيات التعريفية

• Name	الاسم
• Age	العمر
• Sex	الجنس
• Marital status	الحالة الزوجية
• Occupation	المهنة
• Address	العنوان
• Date of interview	تاريخ المقابلة

1 – Present (Chief) Complaint

1 – الشكوى الحالية (الرئيسية)

- Definition: the main complaint that brought the patient to medical attention.
التعريف: الشكوى الرئيسية التي أوصلت المريض إلى الاهتمام الطبي.
- In the patient's own words (try to avoid medical terms; use simple English, e.g. diarrhea to be replaced by watery stool).
بكلمات المريض نفسه (حاول تجنب المصطلحات الطبية؛ استخدم لغة بسيطة، مثلاً يُستبدل الإسهال بـ "براز مائي").
- With duration (in weeks, days, hours, minutes, seconds).
مع المدة (بالأسابيع أو الأيام أو الساعات أو الدقائق أو الثواني).
- If many complaints are given, choose the most bothersome one.
إذا أُعطيت شكاوى كثيرة اختر الأكثر إزعاجاً.
- "What are you complaining of?" / "What is the problem?" / "What is the matter?"
"مما تشكي؟" / "ما المشكلة؟" / "ما الأمر؟"

2 – History of the Present Complaint

2 – قصة الشكوى الحالية

Example: abdominal pain.

مثال: ألم البطن.

Item	البند	Item	البند
Site	الموضع	Radiation	الانتشار
Time and mode of onset	زمن البدء وطريقته	Progression/end	التطور/النهاية
Nature	الطبيعة	Relieving factors	العوامل المخففة
Duration	المدة	Exacerbating factors	العوامل المُفاغمة
Severity	الشدة	Cause	السبب

Characteristics of Pain (SOCRATES) (Table 2.2)

خصائص الألم (SOCRATES) (الجدول 2.2)

Component	المكوّن	Details	التفاصيل
Site	الموضع	Somatic pain, often well localised, e.g. sprained ankle. Visceral pain, more diffuse, e.g. angina pectoris	ألم جسدي، غالباً جيد التموضع، مثل التواء الكاحل. ألم حشوي، أكثر انتشاراً، مثل الذبحة الصدرية
Onset	البدء	Speed of onset and any associated circumstances	سرعة البدء وأي ظروف مرافقة
Character	الصفة	Described by adjectives, e.g. sharp/dull, burning/tingling, boring/stabbing, crushing/tugging, preferably using the patient's own description rather than offering suggestions	توصف بالصفات، مثل حاد/كليل، حارق/وخزي، ثاقب/طاعن، ساحق/شاذّ، ويفضّل استخدام وصف المريض نفسه بدلاً من تقديم اقتراحات
Radiation	الانتشار	Through local extension. Referred by a shared neuronal pathway to a distant unaffected site, e.g. diaphragmatic pain at the shoulder tip via the phrenic nerve (C3, C4)	عبر الامتداد الموضعي. إحالة عبر مسار عصبوني مشترك إلى موضع بعيد غير مصاب، مثل ألم الحجاب الحاجز عند ذروة الكتف عبر العصب الحجابي (C3 وC4)
Associated symptoms	الأعراض المرافقة	Visual aura accompanying migraine with aura. Numbness in the leg with back pain suggesting nerve root irritation	هالة بصرية مرافقة للشقيقة مع الهالة. خدر في الساق مع ألم الظهر يوحي بتخريش جذر عصبي
Timing (duration, course, pattern)	التوقيت (المدة، السير، النمط)	Since onset. Episodic or continuous: if episodic, duration and frequency of attacks; if continuous, any changes in severity	منذ البدء. نوبي أو مستمر: إن كان نوبياً، مدة النوبات وتواترها؛ وإن كان مستمراً، أي تغيّرات في الشدة

Component المكوّن	Details التفاصيل
Exacerbating and relieving factors العوامل المفاقمة والمخفّفة	Circumstances in which pain is provoked or exacerbated, e.g. eating. Specific activities or postures, and any avoidance measures that have been taken to prevent onset. Effects of specific activities or postures, including effects of medication and alternative medical approaches الظروف التي يُستثار فيها الألم أو يتفاقم، مثل الأكل. أنشطة أو أوضاع محددة وأي تدابير تجنّب أُخذت لمنع البدء. تأثيرات أنشطة أو أوضاع محددة، بما فيها تأثيرات الدواء والمقاربات الطبية البديلة
Severity الشدة	Difficult to assess, as so subjective. Sometimes helpful to compare with other common pains, e.g. toothache. Variation by day or night, during the week or month, e.g. relating to the menstrual cycle يصعب تقييمها لأنها ذاتية جداً. أحياناً يفيد المقارنة بآلام شائعة أخرى، مثل ألم الأسنان. التغير بين النهار والليل وخلال الأسبوع أو الشهر، مثلاً المرتبط بالدورة الطمثية

3 – Remaining Questions of the Abnormal System

3 – بقية أسئلة الجهاز غير الطبيعي

- Try to focus on 1 system of blame, e.g. GIT, CVS, CNS.
حاول التركيز على جهاز واحد مُتَّهَم، مثل الجهاز الهضمي أو القلبي الوعائي أو العصبي.
- Ask about other associated symptoms, e.g. if abdominal pain, ask about nausea, vomiting, change in bowel habit...
اسأل عن الأعراض المرافقة الأخرى، مثلاً إذا وُجد ألم بطني اسأل عن الغثيان والإقياء وتغير عادات الأمعاء...

Is It Time to Make a Provisional Diagnosis?

هل حان وقت وضع تشخيص مبدئي؟

- Diagnosis: the identification of the nature of an illness or other problem by examination of the symptoms.
التشخيص: تحديد طبيعة مرض أو مشكلة أخرى بفحص الأعراض.

What are the types of diagnosis? (ما أنواع التشخيص؟)

- Provisional diagnosis: the primary one, based on available information.
التشخيص المبدئي: الأولي، المبني على المعلومات المتاحة.
- Differential diagnosis.
التشخيص التفريقي.
- Final diagnosis: confirmed by lab tests or natural history of the disease.
التشخيص النهائي: يُؤكّد بالفحوص المخبرية أو بالسير الطبيعي للمرض.

Differential Diagnosis or Working Diagnosis

التشخيص التفريقي أو التشخيص العملي

- Most likely – why?
الأكثر احتمالاً – لماذا؟
- Less likely – why?
الأقل احتمالاً – لماذا؟

- Least likely – why?

الأقل احتمالاً على الإطلاق – لماذا؟

Diagnosis

التشخيص

Any diagnosis consists of: anatomical part + pathological part.

يتألف أي تشخيص من: جزء تشريحي + جزء مرضي.

Examples (أمثلة)

- Breast cancer
- Peptic ulcer
- Fracture femur
- Irritable bowel syndrome
- Ischemic heart disease

سرطان الثدي

القرحة الهضمية

كسر الفخذ

متلازمة القولون العصبي

مرض القلب الإقفاري

3. REVIEW OF SYSTEMS AND OTHER HISTORIES | مراجعة الأجهزة والقصص الأخرى

4 – Review of Systems

4 - مراجعة الأجهزة

- The gastrointestinal system
- The respiratory system
- The cardiovascular system
- The urogenital system
- Endocrine
- The nervous system
- The musculoskeletal system

الجهاز الهضمي

الجهاز التنفسي

الجهاز القلبي الوعائي

الجهاز البولي التناسلي

الغدد الصم

الجهاز العصبي

الجهاز العضلي الهيكلي

Questions to Ask About Common Symptoms (Table 2.3)

أسئلة عن الأعراض الشائعة (الجدول 2.3)

System	Questions	الأسئلة
الجهاز القلبي الوعائي	Cardiovascular	Do you ever have chest pain or tightness? Do you ever wake up during the night feeling short of breath? Have you ever noticed your heart racing or thumping? هل تشعر أحياناً بالألم أو انضغاط في الصدر؟ هل تستيقظ أحياناً أثناء الليل وأنت تشعر بضيق النفس؟ هل لاحظت أن قلبك يخفق بسرعة أو يدق بقوة؟
الجهاز التنفسي	Respiratory	Are you ever short of breath? Have you had a cough? If so, do you cough anything up? What colour is your phlegm? Have you ever coughed up blood? هل يضيّق نفسك أحياناً؟ هل لديك سعال؟ وإن كان فهل تخرج شيئاً بالسعال؟ ما لون بلغمك؟ هل سعلت دماً يوماً؟
الجهاز الهضمي	Gastrointestinal	Are you troubled by indigestion or heartburn? Have you noticed any change in your bowel habit recently? Have you ever seen any blood or slime in your stools? هل يزعجك عسر الهضم أو الحرقة؟ هل لاحظت أي تغيير في عادات الأمعاء مؤخراً؟ هل رأيت يوماً دماً أو مخاطاً في برازك؟
الجهاز البولي التناسلي	Genitourinary	Do you ever have pain or difficulty passing urine? Do you have to get up at night to pass urine? If so, how often? Have you noticed any dribbling at the end of passing urine? Have your periods been quite regular? هل تعاني أحياناً ألماً أو صعوبة في التبول؟ هل تضطر للاستيقاظ ليلاً للتبول؟ وإن كان فكم مرة؟ هل لاحظت تقطّر البول في نهاية التبول؟ هل كانت دورتك الطمثية منتظمة تماماً؟
الجهاز العضلي الهيكلي	Musculoskeletal	Do you have any pain, stiffness or swelling in your joints? Do you have any difficulty walking or dressing? هل لديك ألم أو تورم في مفاصلك؟ هل تواجه صعوبة في المشي أو ارتداء الملابس؟

System الجهاز	Questions الأسئلة
Endocrine الصماوي	Do you tend to feel the heat or cold more than you used to? Have you been feeling thirstier or drinking more than usual? هل تميل إلى الشعور بالحر أو البرد أكثر مما اعتدت؟ هل تشعر بعطش أكبر أو تشرب أكثر من المعتاد؟
Neurological العصبي	Have you ever had any fits, faints or blackouts? Have you noticed any numbness, weakness or clumsiness in your arms or legs? هل أصبت يوماً بنوبات أو إغماءات أو فقدان وعي؟ هل لاحظت خدرًا أو ضعفًا أو خرقًا في ذراعيك أو ساقيك؟

Gastrointestinal System

الجهاز الهضمي

Items البند	More items بنود إضافية
Appetite الشهية	Heartburn الحرقة
Diet النظام الغذائي	Vomiting الإقياء
Weight الوزن	Haematemesis التقيؤ الدموي
Teeth and taste الأسنان والطعم	Abdominal pain ألم البطن
Swallowing البلع	Abdominal distension انتفاخ البطن
Regurgitation القلس	Defecation التغوط
Flatulence الغازات	Change of colour of skin تغير لون الجلد

The Respiratory System

الجهاز التنفسي

• Cough	السعال
• Sputum	القشع (البلغم)
• Hemoptysis	نفث الدم
• Dyspnea	ضيق النفس

- Orthopnea
- Chest pain

ضيق النفس الاضطجاعي
ألم الصدر

The Cardiovascular System

- Chest pain
- Dyspnea
- Orthopnea
- Palpitations
- Cough and sputum
- Dizziness and headache
- Ankle swelling
- Peripheral vascular symptoms

الجهاز القلبي الوعائي
ألم الصدر
ضيق النفس
ضيق النفس الاضطجاعي
الخفقان
السعال والقشع
الدوخة والصداع
تورم الكاحلين
الأعراض الوعائية المحيطية

The Urogenital System

الجهاز البولي التناسلي

Urinary البولي	Genital التناسلي
Pain الألم	Scrotum and urethra الصفن والإحليل
Oedema الوذمة	Menstruation الطمث
Thirst العطش	Pregnancies الحمول
Micturition التبول	Breasts الثديان
Urine البول	Secondary sex characteristics الصفات الجنسية الثانوية

The Nervous System

- Mental state
- Conscious level
- Fits and abnormal movements
- TIAs = transient ischemic attacks
- Loss of sensations
- Paraesthesia (pins and needles)
- Speech difficulties
- Unsteadiness

الجهاز العصبي

الحالة العقلية

مستوى الوعي

النوبات والحركات غير الطبيعية

النوبات الإقفارية العابرة (TIAs)

فقدان الحس

المذل (الخدر والوخز)

صعوبات الكلام

عدم الثبات

The Musculoskeletal System

- Pain
- Swelling
- Limitation of movements of any joint

الجهاز العضلي الهيكلي

الألم

التورم

تحدد حركة أي مفصل

5 – Past Medical History

- Any hospitalization
- TB = tuberculosis
- Diabetes mellitus
- Hypertension
- Asthma

5 - القصة المرضية السابقة

أي دخول إلى المستشفى

السل

داء السكري

ارتفاع ضغط الدم

الربو

- Rheumatic fever

الحمى الرثوية

- Contact with patients with hepatitis or AIDS

التماس مع مرضى التهاب الكبد أو الإيدز

6 – Past Surgical History

6 - القصة الجراحية السابقة

- Previous operations

عمليات سابقة

- Blood transfusion

نقل الدم

- Any complications with anesthesia

أي مضاعفات مع التخدير

- Bleeding tendencies

الميل للنزف

7 – Drug History

7 - القصة الدوائية

- Steroids

الستيروئيدات

- Non-steroidal anti-inflammatory drugs

مضادات الالتهاب غير الستيروئيدية

- Insulin and other oral hypoglycemic drugs

الإنسولين وأدوية خفض السكر الفموية الأخرى

- Antihypertensive drugs

أدوية خفض الضغط

- Hormone replacement therapy

المعالجة الهرمونية التعويضية

8 – Immunizations

8 - التلقيحات

- DPT = diphtheria, pertussis, tetanus

الدفتيريا والسعال الديكي والكزاز = DPT

- Measles

الحصبة

- Mumps

النكاف

- Rubella

الحصبة الألمانية

- Poliomyelitis

شلل الأطفال

- TB

السل

- Smallpox

الجدري

- Typhoid

التيفوئيد

9 – Family History

9 – القصة العائلية

- Health and age or cause of death of the patient's parents, brothers and sisters.
صحة وأعمار أو سبب وفاة والدي المريض وإخوته وأخواته.
- Presence of common illnesses (DM, HT, asthma) in the family.
وجود أمراض شائعة (السكري، ارتفاع الضغط، الربو) في العائلة.
- Consanguinity
القرابة الدموية (زواج الأقارب)

10 – Social History and Habits

10 – القصة الاجتماعية والعادات

- Marital status
الحالة الزوجية
- Hazards of occupation
مخاطر المهنة
- Social status – type of residence
الوضع الاجتماعي – نوع السكن
- Travel abroad – dates
السفر إلى الخارج – التواريخ
- Smoking
التدخين
- Alcohol drink
شرب الكحول
- Any unusual?
أي شيء غير معتاد؟

Summary

الخلاصة

- Patient's name, age and sex.
اسم المريض وعمره وجنسه.
- Complaint and the most important positive characteristics of his/her complaint.
الشكوى وأهم الصفات الإيجابية لشكواه.

- The most important negative features of his/her complaint.

أهم الملامح السلبية لشكواه.